

Hinweis / Notice

Akte: krankenhausrecht-md-intensivabrechnung-halle

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

09_chat_dienstplan_und_reanimation.txt

Export aus dem Stationschat ITS 2 · 24.01.2026

08:57 Dr. Leonie Tesch: Morgenrunde abgeschlossen. Jochen Wendt heute weiter High Flow 35 Liter, Kreislauf stabil.

09:04 Zentrale: Reanimation B2 Zimmer 214, Intensivteam sofort.

09:05 Dr. Leonie Tesch: Ich gehe mit Pflegekraft Möller nach B2. Daniel, du bleibst auf ITS 2 und rufst mich bei jeder Änderung direkt an.

09:06 Dr. Daniel Pohl: Verstanden. Ich bin am Arztstützpunkt, Telefon 419.

09:42 Dr. Daniel Pohl: Bei Wendt MAP 68, Noradrenalin unverändert. Blutgas ist da, ich stelle es in die Kurve.

10:03 Dr. Leonie Tesch: Reanimation läuft noch. Gibt es auf ITS etwas Dringendes?

10:04 Dr. Daniel Pohl: Nein. Wendt stabil, Zimmer 8 Bronchoskopie beendet, Oberarzt Riemer ist jetzt auch hier.

10:14 Dr. Leonie Tesch: Zurück auf ITS 2.

10:18 Pflegekraft Eva Lenz: Wendt gelagert, Sättigung 95 Prozent. Eintrag ist fertig.

07_email_medizincontrolling_an_intensivstation.eml

Von	Sabine Lodemann <s.lodemann@klinikum-saalebogen.de>
An	"Dr. Leonie Tesch" <l.tesch@klinikum-saalebogen.de>
Kopie	"Prof. Dr. Marius Birkner" <m.birkner@klinikum-saalebogen.de>, Recht <recht@klinikum-saalebogen.de>
Datum	Thu, 14 May 2026 08:26:00 +0200
Betreff	Fall Wendt / Aufrechnung 74612.80 EUR / Rückseite 17.01.

Guten Morgen Frau Dr. Tesch,

die Kasse hat gestern die Kürzung eingestellt. Der MD schreibt, beim 17.01. habe die Rückseite des Papierbogens gefehlt. In unserem Scanordner liegt tatsächlich nur die Vorderseite. Frau Kühne aus dem Archiv meint, der Originalordner sei nach dem Umzug der ITS 2 noch in Kiste 14 im Kellerraum K-03.

Können Sie außerdem kurz erklären, wer am 24.01. zwischen 09:05 und 10:14 Uhr die unmittelbare Stationsverantwortung hatte, als Sie bei der Reanimation auf B2 waren? Im Dienstplan steht Dr. Pohl, in der Organisationsanweisung aber nur die allgemeine Vertretungsregel. Ich brauche keine juristische Einschätzung, sondern Namen, Uhrzeiten und vorhandene Belege.

Viele Grüße
Sabine Lodemann
Leitende Kodierfachkraft
Telefon 0345 728 3841

08_email_archiv_fund_papierbogen.eml

Von	Kathrin Kühne <k.kuehne@klinikum-saalebogen.de>
An	Sabine Lodemann <s.lodemann@klinikum-saalebogen.de>
Kopie	"Dr. Leonie Tesch" <l.tesch@klinikum-saalebogen.de>
Datum	Mon, 18 May 2026 16:12:00 +0200
Betreff	Kiste 14 gefunden – Tagesbogen Wendt 17.01. vollständig
Anlagen	260112-88341_tagesbogen_2026-01-17_vollstaendig.pdf

Hallo Frau Lodemann,

wir haben Kiste 14 heute um 15:35 Uhr mit Herrn Böhme aus dem Gebäudeservice geöffnet. Der Tagesbogen Wendt vom 17.01. liegt vollständig darin, Vorder- und Rückseite sind zusammengetackert. Auf der Rückseite stehen die Einzelwerte, die Handzeichen LZ und MB sowie ein Vermerk zur Noradrenalinsteigerung um 03:18 Uhr.

Ich habe beide Seiten mit 300 dpi als eine Datei gescannt und im revisionsgeschützten Archiv unter 260112-88341 abgelegt. Das Papieroriginal bleibt in Fach K-03-14-7. Bitte sagt mir, ob ein dokumentierter Auszug an die Kasse oder nur an die Rechtsabteilung gehen soll.

Viele Grüße

Kathrin Kühne

Zentralarchiv · Durchwahl 2274

10_saps_tiss_tageswerte.csv

Datum	SAPS_II	TISS	Gesamt	Quelle	Freigabe	Hinweis
2026-01-12	41	32	73	Intensivsystem	signiert	Aufnahme 19:42
2026-01-13	44	38	82	Intensivsystem	signiert	Revision
2026-01-14	47	41	88	Intensivsystem	signiert	Dialysebeginn
2026-01-15	42	35	77	Intensivsystem	signiert	
2026-01-16	38	31	69	Intensivsystem	signiert	
2026-01-17	36	29	65	Papierbogen	Handzeichen LZ MB	Rückseite im Erstupload fehlte
2026-01-18	40	34	74	Intensivsystem	signiert	
2026-01-19	35	27	62	Intensivsystem	signiert	Leitungswechsel
2026-01-20	30	24	54	Intensivsystem	signiert	Extubation
2026-01-21	37	31	68	Intensivsystem	signiert	
2026-01-22	39	37	76	Intensivsystem	korrigiert 2026-01-23	Dialysezeit ergänzt
2026-01-23	33	26	59	Intensivsystem	signiert	
2026-01-24	29	23	52	Intensivsystem	signiert	Reanimation B2
2026-01-25	28	21	49	Intensivsystem	signiert	
2026-01-26	24	19	43	Intensivsystem	signiert	
2026-01-27	21	17	38	Intensivsystem	signiert	
2026-01-28	18	14	32	Intensivsystem	signiert	Verlegung 11:18

11_rechnung_aufrechnung_fallliste.csv

Fallnummer	Rechnungsdatum	Ursprungsbetrag_EUR	Zahlung_EUR	Aufrechnung_EUR	Status	Bezug
260112-88341	2026-02-10	132488.17	132488.17	-74612.80	streitige Kürzung	Jochen Wendt
260401-11402	2026-04-12	18442.50	0.00	18442.50	für Aufrechnung benannt	unstrittig
260405-12881	2026-04-16	27611.20	0.00	27611.20	für Aufrechnung benannt	unstrittig
260411-14309	2026-04-22	19874.10	0.00	19874.10	für Aufrechnung benannt	unstrittig
260418-15577	2026-04-29	8685.00	0.00	8685.00	für Aufrechnung benannt	unstrittig

12_foto_archivkiste_14.jpg



Bilddatei: 12_foto_archivkiste_14.jpg

Entlassungsbericht Intensivstation ITS 2

Patient	Jochen Wendt, geb. 04.06.1959
Fallnummer	260112-88341
Aufenthalt ITS	12.01.2026, 19:42 Uhr bis 28.01.2026, 11:18 Uhr
Weiterbehandlung	Allgemeinstation C3 bis 03.02.2026

1. Aufnahmegrund

Notfallmäßige Übernahme aus dem Operationssaal nach Ösophagusresektion wegen einer Anastomoseninsuffizienz mit Mediastinitis und septischem Kreislaufversagen. Bei Aufnahme war der Patient invasiv beatmet, mit Noradrenalin kreislaufunterstützt und über einen zentralvenösen Katheter versorgt. Ehefrau Irmgard Wendt wurde am 12.01.2026 um 21:06 Uhr telefonisch informiert.

2. Verlauf

Am 13.01. erfolgten Revision und Spülung des Mediastinums. Vom 12.01. bis 20.01. bestand invasive Beatmung, anschließend High-Flow-Sauerstofftherapie mit wiederholten nichtinvasiven Unterstützungsphasen. Nierenersatztherapie wurde vom 14.01. bis 18.01. durchgeführt. Eine erneute Kreislaufinstabilität trat in der Nacht vom 21. auf den 22.01. auf. Oberärztin Dr. Leonie Tesch übernahm die Behandlungsleitung am 19.01. während der Fortbildung von Chefarzt Prof. Dr. Birkner.

Die täglichen SAPS-II- und TISS-Erhebungen wurden im Intensivsystem dokumentiert. Für den 17.01. fehlt im exportierten Datensatz die elektronische Signatur des Frühdienstes; der Papierbogen trägt die Handzeichen LZ und MB. Für den 22.01. wurde ein nachträglicher Korrekturbeitrag angelegt, weil die Dialyseleistung zunächst dem Vortag zugeordnet war.

3. Entlassungszustand

Bei Verlegung auf Station C3 war Herr Wendt wach, kontaktfähig und mit zwei Litern Sauerstoff über Nasenbrille stabil. Die Ernährung erfolgte über Jejunalsonde. Physiotherapeutische Mobilisation bis an die Bettkante war möglich. Die weitere Wundversorgung und antibiotische Therapie wurden an die Station übergeben.

Dr. med. Leonie Tesch

Oberärztin · Zusatzweiterbildung Intensivmedizin

Leistungsnachweis Fall 260112-88341

Erstellt

Kodierfachkraft

Abrechnungsstand

OPS-Gruppe

10.02.2026, 15:20 Uhr

Sabine Lodemann

Version 3 nach Freigabe Medizincontrolling

8-98f, Aufwandspunkte aus SAPS II und TISS

1. Behandlungsorganisation

Die Station ITS 2 verfügt über zwölf Betten. Die ärztliche Behandlungsleitung lag bei Prof. Dr. Marius Birkner und vom 19.01. bis 23.01. bei Dr. Leonie Tesch. Die Dienstpläne weisen in diesem Zeitraum rund um die Uhr einen auf der Station eingesetzten Arzt aus. Am 24.01. war Dr. Tesch von 09:05 bis 10:14 Uhr bei einer Reanimation auf Station B2; Assistenzarzt Dr. Pohl blieb auf ITS 2.

2. Dokumentationsabweichungen

Für den 17.01. liegt im Datenexport kein finaler Freigabestatus vor, obwohl der Papierbogen Werte und Handzeichen enthält. Für den 22.01. ist die Dialyseleistung durch einen Korrekturbeitrag vom 23.01. ergänzt. Die ursprüngliche und die korrigierte Version sind im Archiv erhalten. In der Pflegeplanung des Nachtdienstes 16./17.01. fehlt die zweite Gegenzeichnung für die Lagerungsmaßnahme.

3. Abrechnung

Die Summe des Klinikexports beträgt 1246 Aufwandspunkte. Ohne den 17.01. und ohne den korrigierten Dialysebeitrag ergäben sich 1038 Punkte. Die Gruppierung führte zusammen mit den Beatmungs- und Operationsdaten zu einem Rechnungsbetrag von 132488.17 EUR einschließlich Pflegeentgelt. Die Krankenkasse zahlte zunächst unter Vorbehalt.

4. Tageswerte

Datum	SAPS II	TISS	Summe	Freigabe
12.01.	41	32	73	signiert
13.01.	44	38	82	signiert
17.01.	36	29	65	Papierbogen
22.01.	39	37	76	korrigiert
28.01.	18	14	32	signiert

Sabine Lodemann

Leitende Kodierfachkraft

Datum

19.02.2026

Zeichen

KH-260112-88341 / GH-922174

Prüfanzeige zum Behandlungsfall Jochen Wendt – Aufnahme 12.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Prüfgegenstand

Wir leiten eine Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit und der Voraussetzungen der abgerechneten intensivmedizinischen Komplexbehandlung ein. Auffällig sind die nachträgliche Änderung von Aufwandspunkten, ein fehlender Freigabestatus am 17.01.2026 und die dokumentierte Abwesenheit der Behandlungsleitung am 24.01.2026.

2. Beauftragter Medizinischer Dienst

Der Medizinische Dienst Sachsen-Anhalt erhält den Prüfauftrag elektronisch. Bitte übermitteln Sie die angeforderten Unterlagen ausschließlich über den vereinbarten Übermittlungsweg. Die Anforderung des Medizinischen Dienstes bestimmt Umfang und Frist. Nicht angeforderte Unterlagen werden von uns nicht vorab bewertet.

3. Zahlungsstatus

Die Rechnung vom 10.02.2026 über 132488,17 EUR wurde am 17.02.2026 unter Vorbehalt ausgeglichen. Eine spätere Korrektur oder Aufrechnung bleibt vorbehalten. Unser Schreiben enthält noch keine abschließende Kürzungsentscheidung.

Mit freundlichen Grüßen

Marvin Kleeberg

Fallmanager stationäre Versorgung · Durchwahl 0341 219 77 416

Klinikum Saalebogen gGmbH
Medizincontrolling
Merseburger Straße 118
06110 Halle (Saale)

Datum

23.02.2026

Zeichen

MD-KH 26/18841

Unterlagenanforderung – Fall Jochen Wendt – Fallnummer 260112-88341

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Benötigte Unterlagen

Bitte übermitteln Sie bis zum 23.03.2026 den vollständigen Intensivkurvenexport, die SAPS-II- und TISS-Tagesbögen, Beatmungsdaten, Dialyseprotokolle, ärztlichen und pflegerischen Dienstpläne, Nachweise über die Behandlungsleitung sowie die Versionshistorie der Korrekturinträge vom 22. und 23.01.2026.

2. Fragestellung

Zu beurteilen ist, ob die dokumentierten Leistungen und Strukturvoraussetzungen für die abgerechnete OPS-Gruppe im gesamten geltend gemachten Zeitraum vorlagen und ob die Aufwandspunkte nachvollziehbar ermittelt wurden. Die medizinische Notwendigkeit der stationären Behandlung als solche ist nicht Gegenstand des Auftrags.

3. Übermittlung

Jede Datei ist mit Fallnummer und Dokumentart zu benennen. Bei technischen Schwierigkeiten ist vor Fristablauf Frau Nele Thormann unter der Durchwahl 0391 5661 442 zu kontaktieren. Ein Uploadprotokoll wird nach Abschluss der Übertragung bereitgestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Jasper Rohwedder

Facharzt für Anästhesiologie · Sozialmedizin

Gutachtliche Stellungnahme nach Aktenlage

Aktenzeichen
Versicherter
Begutachtung
Gutachter

MD-KH 26/18841
Jochen Wendt, geb. 04.06.1959
28.04.2026
Dr. med. Jasper Rohwedder

1. Auftrag und Material

Geprüft wurden Abrechnung, Entlassungsbericht, Intensivkurvenexport, 17 Tagesbögen, Beatmungs- und Dialyseprotokolle, Dienstpläne sowie die vom Krankenhaus am 22.03.2026 übermittelte Versionshistorie. Der Papierbogen für den 17.01.2026 lag als Scan vor. Die Rückseite mit Erläuterungen war im Upload nicht enthalten.

2. Medizinischer Verlauf

Die intensivmedizinische Behandlungsbedürftigkeit während des streitigen Zeitraums ist anhand der Organunterstützung und der wiederholten Kreislaufinstabilität nachvollziehbar. Die Beatmungszeiten lassen sich aus Geräteexport und Kurve im Wesentlichen abgleichen. Für zwei High-Flow-Intervalle unterscheiden sich die Zeitangaben um jeweils ungefähr 35 Minuten.

3. Aufwandspunkte

Die elektronisch signierten Tageswerte sind rechnerisch nachvollziehbar. Für den 17.01. fehlt die Rückseite des Papierbogens; die dort angesetzten 65 Punkte können aus dem übrigen Export nicht vollständig rekonstruiert werden. Beim 22.01. ist der Korrekturbeitrag technisch nachvollziehbar, die medizinische Begründung nennt jedoch keine Uhrzeit der Dialyseaufnahme.

4. Behandlungsleitung

Die Dienstpläne benennen Prof. Dr. Birkner und Dr. Tesch. Für den 24.01. ist eine Abwesenheit von 69 Minuten wegen eines Reanimationseinsatzes dokumentiert. Ob und wie die Verantwortung während dieses Einsatzes organisatorisch fortgeführt wurde, ergibt sich aus der vorgelegten Organisationsanweisung nur teilweise.

5. Mitteilung an die Krankenkasse

Die abschließende sozialmedizinische Beurteilung wird der beauftragenden Krankenkasse im vorgesehenen elektronischen Datensatz übermittelt. Dieses Exemplar dokumentiert die tatsächlichen Feststellungen und die verbliebenen Dokumentationslücken.

Dr. med. Jasper Rohwedder

Facharzt für Anästhesiologie · Sozialmedizin

Datum

12.05.2026

Zeichen

KH-260112-88341 / GH-922174

Rechnungskorrektur und Aufrechnung – 74612.80 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Korrekturbetrag

Nach Abschluss der Prüfung erkennen wir die abgerechnete intensivmedizinische Komplexbehandlung nicht im geltend gemachten Umfang an. Aus der Neugruppierung ergibt sich gegenüber der Zahlung vom 17.02.2026 eine Differenz von 74612.80 EUR. Die medizinische Notwendigkeit des stationären Aufenthalts bleibt unberührt.

2. Verrechnung

Wir rechnen den Betrag mit den in der Anlage bezeichneten unstreitigen Forderungen aus den Fällen 260401-11402 bis 260418-15577 auf. Die Buchung ist für den Zahlungslauf 20.05.2026 vorgesehen. Der Prüfaufschlag wird nach gesonderter Prüfung abgerechnet.

3. Erörterung

Falls Sie die Korrektur nicht akzeptieren, teilen Sie dies bis zum 02.06.2026 unter Angabe unseres Zeichens mit. Benennen Sie bitte konkret, welche Tatsachenfeststellung oder Berechnung angegriffen wird. Die bereits ausgetauschten Unterlagen werden nicht erneut angefordert.

Mit freundlichen Grüßen

Marvin Kleeberg

Fallmanager stationäre Versorgung

Anlagen

1. Aufstellung der Aufrechnungsforderungen
2. Korrekturdatensatz vom 11.05.2026